

MÓDULO: SEMIOTÉCNICA DE TECIDOS MOLES E DUROS DA BOCA; ROTINA DE AMBULATÓRIO; PRONTUÁRIO.

PROFESSOR: MIKAEL MENDES

PRONTUÁRIO E ROTINA DE ATENDIMENTOS

- VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PRONTUÁRIO
- USO DO PRONTUÁRIO NA ATENÇÃO BÁSICA
- ATRIBUIÇÕES DO DENTISTA NA ATENÇÃO BÁSICA
- ROTINA DE ATENDIMENTOS NA AB (PÚBLICO)
- PRIMEIRA VEZ, RETORNOS, LIVRE DEMANDA (DEMANDA ESPONTÂNEA), ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, ATENDIMENTO NO DIA

SAÚDE		FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL		EXATADO POR:	DATA:									
CONFIRMADO POR:		FOLHA Nº:												
CNS DO PROFISSIONAL*	CBO*	CNES*	IRE*	DATA*										
CNS DO PROFISSIONAL	CBO	CNES	IRE											
Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TURNO*														
Nº PRONTUÁRIO														
CNS OU CPF DO CIDADÃO														
Data de nascimento*														
Sexo* (F) Feminino (M) Masculino														
Local de atendimento* (ver legend)														
Paciente com necessidades especiais														
Consultas agendadas														
Escuta inicial/orientação														
Consulta no dia														
Atendimento de urgência														

Quadro 4.4 – Tipo de atendimento*

CAMPO	ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO
CONSULTA AGENDADA	É toda consulta realizada após agendamento, de caráter não urgente . Pode ser oriunda da demanda espontânea que não foi atendida no mesmo dia da procura, mas tinha indicação e foi agendada para outro dia ou em casos de retorno dos atendimentos. Por exemplo, uma consulta de retorno agendada para a continuidade do tratamento previsto na primeira consulta odontológica individual.
DEMANDA ESPONTÂNEA	
ESCUTA INICIAL/ORIENTAÇÃO	Refere-se à escuta/orientação realizada no momento em que o usuário chega ao serviço de saúde, relatando queixas ou sinais e sintomas percebidos por ele. Não inclui as orientações de fluxos dentro da UBS informados pela recepção. Durante o acolhimento e escuta qualificada, o profissional, quando possível, resolverá o caso por meio de orientação. Caso contrário, deve ser realizada a classificação de risco e análise de vulnerabilidade para o encaminhamento do usuário em situação aguda ou não. Um exemplo é a mãe que procura a equipe de Saúde Bucal para orientações quanto à cronologia de erupção dentária de seu bebê. Após a escuta, a equipe orienta a mãe.



CONSULTA NO DIA	É a consulta que é realizada no mesmo dia em que o usuário busca o serviço, de caráter não urgente. Pode representar também a consulta realizada no dia por haver disponibilidade na agenda do profissional. Por exemplo, um usuário procura a UBS para atendimento odontológico sem relato de urgência; e, ao verificar disponibilidade na agenda, o profissional realiza o atendimento no mesmo dia e mediante a necessidade garante o retorno do usuário para continuidade do tratamento.
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	É o atendimento realizado ao usuário acometido por quadros agudos ou agudizações de patologias crônicas, podendo haver possibilidade de agravamento do quadro que determina a necessidade de assistência imediata para alívio do sofrimento físico e/ou psíquico, recuperação do estado de saúde, estabilização/suporte de vida e/ou encaminhamento a outro ponto da rede quando necessário, por exemplo usuário procura atendimento odontológico com queixa de dor dentária espontânea, necessita de atendimento odontológico no mesmo turno.

Fonte: SAS/MS.

* Campo de preenchimento obrigatório.

Quadro 4.5 – Tipo de consulta**

CAMPO	ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	Consiste na avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de plano preventivo-terapêutico . O tratamento deve ser iniciado na mesma sessão da primeira consulta odontológica programática.
	É importante lembrar que nessa consulta acontece uma minuciosa análise dos dentes e tecidos moles e o paciente tem todas as explicações e orientações quanto ao seu caso. Também é feito um levantamento do histórico do paciente tanto da sua condição oral, quanto de saúde geral. Para que se estabeleça uma relação de confiança/vínculo deve-se ouvir, com atenção, as queixas e dúvidas do paciente. Uma primeira consulta odontológica programática só poderá ser registrada novamente para a mesma pessoa 12 (doze) meses após a conclusão do plano preventivo-terapêutico ou caso o paciente abandone o tratamento 6 (seis) meses após a última consulta. Não devem ser considerados como primeira consulta odontológica programática os atendimentos eventuais, por exemplo, os de urgência/emergência/consulta no dia que não têm elaboração de plano preventivo-terapêutico e seguimento do tratamento previsto. As necessidades do usuário levantadas durante esta avaliação deverão ser registradas no prontuário clínico do usuário.
CONSULTA DE RETORNO EM ODONTOLOGIA	Consiste na(s) consulta(s) subsequente(s) do usuário que está em continuidade do tratamento iniciado e programado por meio da primeira consulta odontológica programática. Portanto será registrada a consulta de retorno acrescida do(s) procedimento(s) realizado(s) neste dia . (Exemplo: Considerando que um usuário possui seis restaurações para serem feitas, segundo plano preventivo-terapêutico elaborado pelo CD. Dessa forma as consultas agendadas para a realização dessas restaurações deverão ser consideradas como “CONSULTA DE RETORNO EM ODONTOLOGIA”.
CONSULTA DE MANUTENÇÃO EM ODONTOLOGIA	Consiste na consulta do usuário para manutenção, acompanhamento ou reparos clínicos após este ter concluído o tratamento previsto na primeira consulta odontológica . Ocorre quando o retorno do usuário ocorre em um período inferior a 12 meses da conclusão do tratamento. Portanto será registrada a consulta de manutenção acrescida do(s) procedimento(s) realizado(s) neste dia . (Exemplo: O usuário conclui o tratamento no mês de julho e no mês de setembro do mesmo ano ele retorna ao atendimento odontológico para reparo em uma determinada restauração. Neste caso deve-se marcar “CONSULTA DE MANUTENÇÃO EM ODONTOLOGIA” pois o retorno do usuário ocorreu dois meses após a conclusão do tratamento.

Fonte: SAS/MS.



TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR	A condição de indivíduo que sofreu traumatismo dentoalveolar independe do número de dentes, permanente e/ou decíduo, afetados e do tipo de lesão.
NÃO IDENTIFICADO	Deve ser preenchido todas as vezes que não for identificada nenhuma condição de vigilância em saúde bucal descrita acima.

Fonte: SAS/MS.

SINAIS

todo dado sobre a doença que pode ser percebido objetivamente e captado diretamente, pelos órgãos dos sentidos do profissional, durante o exame físico, frequentemente pelas lesões fundamentais; ou captado indiretamente por exames complementares

SINTOMAS

tudo o que é percebido, sentido, vivenciado subjetivamente e relatado pelo paciente (PAC) na anamnese (p. ex., dor, parestesia, anestesia, queimação, sentimentos, opiniões, apreensões, percepções etc.)

SEMIOLOGIA

- **SEMIOTÉCNICA** : métodos para obter e reconhecer os sinais e sintomas, isto é, a sintomatologia ou o quadro clínico
- **PROPEDÊUTICA**: ordenação dos sinais semiotécnicos, para levantamento de hipóteses e diagnóstico
- **SEMIOGENESE**: estudos da etiofisiopatogenia
- Sinais e/ou sintomas **patognomônicos** levam ao diagnóstico final, pois somente podem se expressar em uma única doença (entidade diagnóstica).

PRONTUÁRIO

- Todos os encontros entre o PAC e o PS envolvem o registro das informações (semiografia, notação dos sinais e sintomas) em um formulário próprio.
- VALOR CLÍNICO E JUDICIAL
- CONFIDENCIAL, acesso reservado aos profissionais, paciente.
- COERÊNCIA ENTRE PRONTUÁRIOS
- Além do exame clínico inicial, todas as consultas subsequentes devem ser datadas e descritas no item “evolução clínica” do prontuário.

EXAME CLÍNICO

- FASE SUBJETIVA OU ANAMNESE
- FASE OBJETIVA OU EXAME FÍSICO

Quadro 4.14

Recursos semióticos usados no exame físico.

- Inspeção: exige a utilização do sentido da visão. Tem como objetivos detectar distorções, discromias e lesões fundamentais mucosas, cutâneas e linfonodais, distúrbios de desenvolvimento, próteses e outros dispositivos.
- Palpação: obtenção de dados por tato e pressão (para regiões mais profundas do corpo). Identifica modificações em estrutura, superfície, espessura, choque de retorno, consistência ou dureza (pétreo, flácido, bomachoso etc.) e volume.
- Percussão: é uma forma de palpação em que, por pequenos golpes diretos (com os dedos ou mãos) ou indiretos (com instrumentos; por exemplo, cabo do espelho), é possível escutar sons. Cada estrutura tem um som característico.
- Ausculta ou auscultação: procedimento que detecta sons do organismo, exceto que, diferentemente da percussão, esse procedimento usa a audição ou instrumentos para magnificar o som (p. ex., o estetoscópio).
- Olfacção: pouco usada em Odontologia, mas pode contribuir para o exame clínico.

ANAMNESE

- **INICIA PELA ANAMNESE!!**
- Na anamnese vale dizer, identificar e recordar os eventos ligados à biografia – história de vida e história psicossocial –, queixa principal, história da doença atual, antecedentes hereditários, hábitos e vícios, história médica e tratamento médico atual do PAC.
- Identificar o paciente
- Profissional deve ter habilidades como objetividade, precisão, sensibilidade, reprodutibilidade, fatores psicossociais, espirituais e pessoais
- SIC ou SIP – quando necessário

EXAME FÍSICO

Enquanto na anamnese os sintomas podem ser descritos pelas palavras usadas pelo PAC, no exame físico realizado pelo profissional, a semiografia deve conter termos técnicos precisos.

RECURSOS SEMIOTÉCNICOS:**INSPEÇÃO**

É facilitada pela aspiração constante da saliva ou secagem com gaze ou ar comprimido e, no exame intraoral, pelo uso de espelho clínico, afastadores, boa iluminação e lupa. As gazes também são usadas para o tracionamento da língua, permitindo melhor visualização.

A transiluminação é um recurso semiotécnico de inspeção que emprega uma fonte de luz para passá-la através de objetos capazes de transmiti-la. Podem-se utilizar os fotopolimerizadores de compósito como fonte luminosa. O método é usado, por exemplo, para a inspeção de tecido cariado interproximal e cavidades sinusais.

A diascopia é um procedimento que emprega uma lâmina de microscopia para comprimir uma área, “isquemiá-la”, e observar o que acontece imediatamente após a descompressão. É usada em lesões com alteração de cor para distinguir se decorre de conteúdo intra ou extravascular. Se a origem for hemática, a compressão empalidecerá o conteúdo intravascular, mas não o extravasado. Se a origem for de um pigmento qualquer que esteja nos tecidos adjacentes aos vasos, a coloração não irá esmaecer com a compressão. A inspeção pode ser direta (sem o uso de instrumentos) e indireta (com instrumentos: microscópio, lupas, espelho etc.).



PALPAÇÃO

O examinador consegue perceber alterações mais profundas e avaliar sua alteração tátil superficial e espessura, consistência, tamanho, compressibilidade, envolvimento dos planos teciduais de pele e mucosa, infiltração, delimitação, mobilidade, sensibilidade à palpação (que nem sempre corresponde à sensibilidade relatada na anamnese), alteração de temperatura e, importante, linfadenomegalia.

Bimanual ou palmopalmar (com ambas as mãos);

Bidigital (com dois dedos de uma mão ou das duas mãos); e digitopalmar (um dedo de uma mão apoiando-se na palma da outra mão e com o objeto entre os dois). A palpação indireta é realizada com instrumentos (p. ex., explorador ou sonda periodontal).

Pela palpação, pode-se isquemiá uma região onde se suspeita haver concentração vascular, detectar aumento de temperatura, sentir crepitação em superfície óssea devido ao adelgaçamento da cortical ou ao choque de retorno quando o conteúdo intraósseo for líquido.

As mais importantes cadeias linfáticas da cabeça são as seguintes:

- Parotídea, localizada na região anteroinferior da orelha.
- Submandibular, sob a borda inferior interna da mandíbula.
- **Submentual, abaixo e atrás do mento. (MENTO, ÁPICE DE LÍNGUA, PARTE ANTERIOR DO SOALHO BUCAL, LABIO INFERIOR E INCISIVOS INFERIORES)**
- Espinal acessória, segue o curso dos nervos espinais acessórios.
- **LINFONODOS JUGULODIGÁSTRICOS: 1/3 posterior da língua, da tonsila palatina e da orofaringe. É palpado em faringites e amigdalites**
- Jugular interna, segue o curso da veia jugular interna.
 - **Está dividida em: jugular superior ou subdigástrica, que drena as amígdalas, língua, mucosa bucal e porções da faringe;**
 - cervical média, que drena a laringe e porções inferiores da faringe; e
 - cervical inferior, que drena a tireoide, porção cervical do esôfago e algumas áreas abaixo da clavícula.

PERCUSSÃO

Na percussão de dentes inicia-se a certa distância do local pesquisado para que o PAC se acostume com as sensações normais e possa facilmente relatar sensibilidade em um dente afetado.

AUSCUTAÇÃO

Podem-se ouvir, por exemplo, os sons emitidos pelos movimentos da ATM, o roçar de fragmentos de osso fraturado e os sons cardíacos. É direta quando não se usam instrumentos e indireta quando são utilizados (p. ex., estetoscópio ou instrumentos para percussão).

OLFAÇÃO

Podem-se obter as alterações das halitoses, do uso de bebidas alcoólicas, o odor cetônico dos diabéticos descompensados, o odor pútrido das necroses teciduais e a emissão intensa das secreções purulentas produzidas pelas bactérias anaeróbicas. Pacientes portadores de pênfigo foliáceo, apesar de não apresentarem lesões bucais, exalam odor característico de “ninho de rato”; tumores malignos avançados conferem ao paciente um hálito putrefato significativo.

PODE SER DIVIDIDO EM GERAL E LOCORREGIONAL (EXTRAORAL E INTRAORAL)

- **EXAME FÍSICO GERAL:** O exame físico começa pela ectoscopia
 - Podem-se observar sexo, estado geral de saúde, idade aparente, estatura, biotipo, tegumento visível, postura, motricidade, ambulação, maneira de cumprimentar e apertar a mão, vestimenta, higiene pessoal, odores, expressões faciais, fâcies, afetividade, reação às pessoas presentes, fala, níveis de percepção e consciência, se vai à consulta só ou acompanhado e a aparente influência do acompanhante sobre o PAC.

Exame físico locorregional extraoral

- OBSERVAR ASPECTO DA FACE, SEIOS PARANASAIS, OLHOS, MUSCULOS MASTIGATÓRIOS, ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, GLANDULAS, LINFONODOS

Exame físico locorregional intraoral

- OBSERVAR LÁBIOS, VESTÍBULO ORAL, ASSOALHO ORAL E LINGUA, MUCOSAS, REBORDO, PALATO, ETC.

Exames Complementares

- Quem chega ao diagnóstico e será responsável por ele é o dentista e não os exames complementares ou qualquer outro recurso semiológico.
- O profissional levará em conta os resultados dos exames complementares, mas não poderá dispensar os outros dados obtidos no exame clínico.
- O EXAME CLÍNICO É SOBERANO!

Quadro 4.25

Linfonodos frequentemente mais palpados no exame físico estomatológico.

- Linfonodos submentais: localizados no plano sagital mediano, dentro do triângulo submental, justapostos ao músculo milio-hióideo, drenam a linha do lábio inferior, dos dentes inferiores, de parte do assoalho oral e parte anterior da mandíbula. Durante a palpção, o profissional de saúde deve se localizar atrás da cabeça e, com a mão esquerda, empurrar gentilmente o paciente para frente, sem desviar do plano sagital, para não diminuir a tensão do músculo platíma e outros músculos mais profundos, e com a mão direita palpar os linfonodos submentais, levando-os de encontro à face interna da região submental do osso mandibular.
- Linfonodos submandibulares: localizados bilateralmente na face medial da porção posterior do corpo mandibular, na mesma região das glândulas submandibulares, drenando a linha da região gengival, bordo lateral e região posterior da língua, tonsilas, assoalho posterior, nariz, palato, mucosa labial, porção lateral dos lábios, glândulas submandibulares e parótida e parte do pescoço. A palpção das cadeias submandibulares pares (direita e esquerda) é realizada inclinando-se a cabeça do paciente lateralmente em relação ao plano sagital, para relaxar a musculatura, na direção do lado que se irá palpar com os mesmos dedos citados, traçando-os do plano sagital para a face medial da região posterior do corpo e região do ângulo mandibular e deslocando os dedos para a região anterior.
- Linfonodos cervicais anteriores profundos direitos e esquerdos: palpados com os dedos por trás e sobre o músculo esternocleidomastoideo, levando-os desde a apófise mastoidea até a região supraclavicular, onde se carregam os dedos na fossa supraclavicular da região próxima ao esterno até a região da axila. Esses linfonodos compreendem duas cadeias: jugular anterior e justavisceral. A cadeia jugular anterior segue o trajeto da veia jugular e é tateada com os dedos na porção anterior do músculo esternocleidomastoideo desde o ângulo mandibular até a extremidade externa da clavícula. Logo abaixo do ângulo mandibular, localiza-se o gânglio tonsilar. A cadeia justavisceral se subdivide em pré-laríngea, pré-tireóide, pré-traqueal e laterotracal. Quando há dúvida quanto à existência de um linfonodo supraclavicular anterior profundo alterado, pede-se ao paciente para tossir, o que pode ajudar na sua exteriorização.
- Linfonodos cervicais superficiais posteriores direitos e esquerdos: são palpados com os dedos na porção anterior do músculo esternocleidomastoideo desde o ângulo mandibular até a extremidade externa da clavícula. Logo abaixo do ângulo mandibular localiza-se o gânglio tonsilar.
- Linfonodos das cadeias occipitais direita e esquerda: são tateados deslizando-se os dedos desde o occipício até a região da nuca.
- Linfonodos de cadeias pré-auriculares e mastoideas direita e esquerda: são palpados adiante e atrás da orelha externa, com os dedos indicador e médio.


Quadro 4.26 Diferenciação clínica entre as inflamações inflamatórias e as neoplasias malignas primárias e metastáticas.

Etiologia	Aumento de volume	Superfície	Infiltração	Mobileidade	Sensibilidade à palpação	Hipertermia ^a	Consistência
Inflamatória	Presente e limitado	Lisa	Não	Sim	Sim	Sim ^b	Borbulhante ou fibrosa
Neoplásica	Presente e ilimitada	Borbulhada ^{***}	Sim	Não	Não ^c	Não ^d	Fibrosa ou dura

^aAumento de temperatura. ^bMais frequente em processos inflamatórios agudos. ^cLesão tumoral que se apresenta com borras, irregularidades ou protuberâncias. ^dInicialmente pode estar sensível. ^eCaridade classicamente como "nódulo frio", embora esteja na temperatura corpórea.

Quadro 4.17 Exemplos de doenças bucais com predisposição por determinado gênero.

Gênero masculino	Gênero feminino
• Carcinoma epidermoide • Carcinoma in situ • Carcinoma verrucoso (de Ackerman) • Dermatite herpetiforme (de Duhring-Brocq) • Estomatite nicotínica • Leucoplasia • Melanoma • Queratoacantoma • Queratoblastoma • Sarcoma osteogênico	• Displasia cementoóssea florida • Displasias fibrosas monostóticas • Displasias fibrosas polistóticas • Gingivite descarnativa • Glossodinia • Granuloma piogênico • Lesão central de células gigantes • Língua geográfica • Osteomielite crônica esclerosante difusa • Síndrome de Sjögren

Quadro 4.18

Sinais vitais.

- Pressão arterial
- Pulso arterial
- Ritmo respiratório
- Temperatura corpórea
- Peso e altura



CONCEITOS

- **DIAGNÓSTICO** – Reconhecer ou identificar as doenças, guiado pelo estado anatômico, funcional e etiológico
- **PROGNÓSTICO**– estudo da duração e término da doença. BOM, RUIM OU DUVIDOSO?
- **TRATAMENTO** – Eliminar ou atenuar o agente etiológico da doença
- **PROSERVAÇÃO** – Acompanhamento ao longo do tempo

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO

- Sistema Internacional
- Sistema Universal ou Americano

Dentes Permanentes no Sistema Internacional																Dentes Permanentes no Sistema Universal/Americano															
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

Dentes Decíduos no Sistema Internacional										Dentes Decíduos no Sistema Universal/Americano									
55	54	53	52	51	61	62	63	64	65	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
81	82	83	84	85	71	72	73	74	75	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K

